



REVISIÓN

Fisioterapia preventiva en las disfunciones del suelo pélvico en el posparto

R. Abalo* e I. Da Cuña

Facultade de Fisioterapia, Universidade de Vigo, Pontevedra, España

Recibido el 4 de mayo de 2012; aceptado el 12 de septiembre de 2012

Disponible en Internet el 23 de diciembre de 2012

PALABRAS CLAVE

Periodo de posparto;
Prevención;
Fisioterapia;
Suelo pélvico;
Embarazo

KEYWORDS

Postpartum period;
Prevention;
Physical therapy;
Pelvic floor;
Pregnancy

Resumen Se realizó una revisión bibliográfica acerca de la actuación de la fisioterapia como prevención de las disfunciones del suelo pélvico en el posparto, para conocer los métodos terapéuticos más empleados.

La búsqueda se llevó a cabo de septiembre del 2011 a enero del 2012 en las bases de datos ENFISPO, Pedro, CINAHL, CSIC, Cochrane Library Plus en español, Cochrane Library, Medline, Pubmed, Wos, Scopus y Sport Discus with full text.

Atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión, se analizaron 14 documentos, en los que se hallaron como procedimientos más utilizados en el periodo posnatal los ejercicios de Kegel, los ejercicios hipopresivos y los ejercicios depresivos con el bebé.

Se ha encontrado escasa bibliografía acerca de las técnicas para la prevención de disfunciones en el posparto. Los métodos que se utilizan no suponen una sobrecarga a nivel asistencial para el fisioterapeuta.

© 2012 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Preventive physical therapy in pelvic floor dysfunction during postpartum

Abstract We made a systematic review on physical therapy as a method to prevent pelvic floor dysfunction in the postpartum period and to determine the most common therapeutic methods used.

The search was carried out from September 2011 to January 2012 using the following databases: ENFISPO, Pedro, CINAHL, CSIC, Spanish Library Cochrane Plus, Cochrane Library, Medline, Pubmed, Wos, Scopus and Sport Discus with full text.

Following the inclusion and exclusion criteria, in 14 studies we found that the most frequently used methods during postnatal period are Kegel exercises, hypopressive exercises and depressive exercises with the baby.

* Autor para correspondencia.

Correos electrónicos: rocioabalo@uvigo.es, rocioabalonu@gmail.com (R. Abalo).

Little bibliography was found on methods to prevent pelvic floor dysfunction in the postpartum period. The methods used do not involve an overload level on the care level for the physical therapist.

© 2012 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

El parto es una de las causas principales de las disfunciones del suelo pélvico, por ejemplo, incontinencia urinaria, incontinencia anorrectal o prolapsos de las vísceras pélvicas^{1,2}.

Estas afecciones conllevan a un problema de salud incapacitante y con repercusiones psicológicas que impiden a la mujer una vida social normal e incluso conllevan alteraciones psicológicas³.

La actuación de la fisioterapia durante el posparto tiene como objetivo la prevención de posibles alteraciones tras el alumbramiento y la recuperación física de la mujer. Así, se proponen trabajos de reeducación postural y fortalecimiento muscular. En este sentido, hay autores que sugieren que a todas las mujeres después del parto se les debería prescribir un programa de entrenamiento del suelo pélvico⁴.

En España, aunque desde 1973 el estatuto jurídico de la Seguridad Social reconoce como competencia de los fisioterapeutas la realización de «ejercicios maternos pre y posparto»⁵; su actuación es minoritaria quizá por la escasez de fisioterapeutas especializados¹.

Además, en 1998, cuando el Insalud desarrolló el plan específico de atención a la mujer, no se reconoce la actuación del fisioterapeuta, lo cual podría contribuir a la poca difusión de esta disciplina. Sin embargo, en otros países sí se contempla la función de este profesional en la atención a la mujer⁶.

Objetivos

Ante la situación en la que se encuentra la asistencia de la fisioterapia a la mujer en el posparto, con esta revisión se persiguen los siguientes objetivos:

- Averiguar la actuación preventiva de la fisioterapia en el posparto con la finalidad de evitar disfunciones del suelo pélvico.
- Conocer las medidas terapéuticas más empleadas.
- Poner de relieve la importancia de la prevención y no solo el tratamiento.

Estrategia de búsqueda

Se realizó una revisión bibliográfica sobre el objeto de estudio a través de las siguientes bases de datos: ENFISPO, Pedro, CINAHL, CSIC, Cochrane Library Plus en español, Cochrane Library, Medline, Pubmed, Wos, Scopus y Sport Discus with full text.

Los descriptores empleados han girado entorno a «*physicaltherapy and delivery*», «*physicaltherapy and postpartum*» y «*physicaltherapy and pregnancy*», aunque estos variarán según el tesoro de cada base de datos. Su búsqueda se realizó en cualquiera de los campos del artículo.

La investigación se llevó a cabo de septiembre del 2011 a enero del 2012 y no se acotó la búsqueda por idiomas.

Al realizar una búsqueda se establecieron los siguientes criterios de inclusión:

- Estudios publicados del 2000 al 2012.
- Estudios que traten la prevención en el posparto.
- Tener acceso al texto completo y como mínimo al resumen.

Los criterios de exclusión fueron:

- Estudios que no traten sobre el objeto de estudio de nuestra investigación.
- Los que se repetían en fuentes distintas e incluso dentro de la misma fuente.
- Estudios que establecían el tratamiento y de fisioterapia a una afección en posparto, no incluyendo la prevención.

Selección de los estudios

La búsqueda bibliográfica en las distintas bases de datos atendiendo al tesoro de cada una de ellas se puede observar en la [tabla 1](#). Atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión, se realizó una preselección de las publicaciones que se adecuaban al objeto de la investigación. Posteriormente, se procedió a la lectura de los abstract. Se excluyeron aquellos a los que no se tenía acceso, los que no eran de interés y los que se repetían. Todos los artículos que se seleccionaron pasaron a formar parte de la revisión para una lectura exhaustiva y en profundidad ([fig. 1](#)).

En total, se encontraron 712 documentos, de los cuales han pasado a la preselección 104; de ellos, 23 se han incluido en nuestra revisión, de los cuales se han repetido 9, por lo tanto, hemos analizado 14 documentos ([fig. 1](#)).

Atendiendo al tipo de estudio, se han analizado 4 revisiones, 3 estudios descriptivos, 2 ensayos clínicos aleatorizados, 2 estudios de casos, 2 guías y 1 tesis ([tabla 2](#)).

Síntesis de resultados

La fisioterapia obstétrica y ginecológica abarca la adolescencia, el periodo de gestación y la menopausia. En el periodo

Tabla 1 Resultado de la búsqueda en las bases de datos

Base de datos/término de búsqueda	Resultados totales	Resultados preseleccionados	Resultados seleccionados
<i>CSIC</i>			
Fisioterapia posparto	2	2	2
<i>Cochrane Library en español</i>			
Fisioterapia posparto	5	2	1
<i>Cochrane Library</i>			
Postdelivery physiotherapy	0	0	0
Pregnancy physiotherapy	0	0	0
Postdelivery	46	2	2
<i>Medline</i>			
Physical therapy modalities and pregnancy	68	18	3
Physical therapy speciality and postpartum period	11	4	3
<i>Pubmed</i>			
Postpartum and physiotherapy	169	17	3
<i>Scopus</i>			
Physical therapy and pregnancy	179	15	3
<i>Sport Discus with full text</i>			
Physiotherapy and pregnancy	28	4	0
Physiotherapy and postpartum	4	3	2
Postnatal exercise and exercise for women	8	1	1
<i>CINAHL</i>			
Physical Therapy and Pregnancy	65	5	3
<i>ENFISPO</i>			
Posparto	30	9	0
Posparto	22	4	0
Posparto y fisioterapia	2	2	0
Postparto y fisioterapia	2	2	0
<i>Pedro</i>			
Physicaltherapy and delivery	25	6	0
<i>Wos</i>			
Pregnancy and physiotherapy	46	8	0

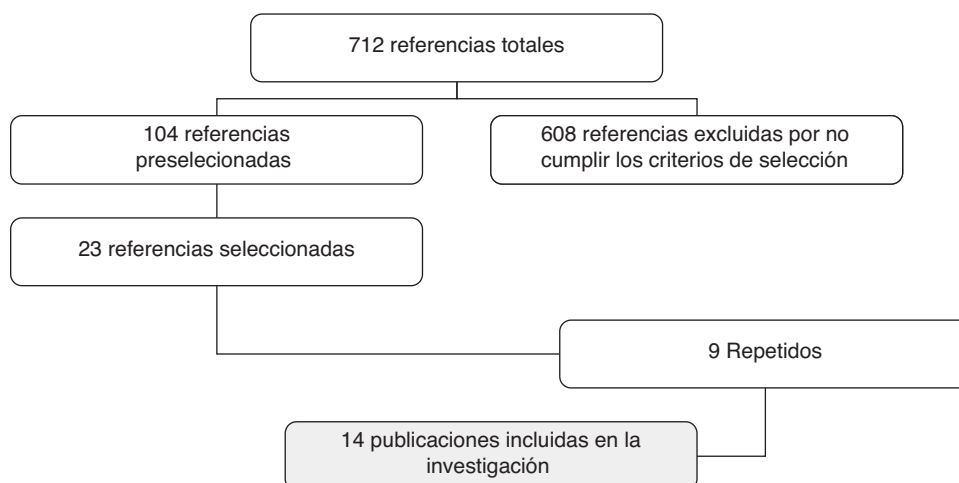
**Figura 1** Procedimiento de selección.

Tabla 2 Artículos según las bases de datos y la fuente de publicación

Bases de datos	Fuente	Título
CSIC	<i>Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología</i> <i>Fisioterapia</i>	Fisioterapia en el primer nivel asistencial: atención a la mujer Prevención de la disfunción del suelo pélvico de origen obstétrico
Cochrane Library	<i>La Biblioteca Cochrane Plus</i>	Entrenamiento de la musculatura del piso de la pelvis para la prevención y tratamiento de la incontinencia fecal y urinaria en mujeres antes y después del parto
Medline	<i>Gynécologie, Obstétrique & Fertilité</i> <i>Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada</i> <i>BMJ (Clinical Research Ed.)</i> <i>Physiotherapy Theory and Practice</i>	Rééducation dans le cadre du post-partum (décembre 2002) Postural health in women: the role of physiotherapy. Promoting urinary continence in women after delivery: randomised controlled trial A return to running program for the postpartum client: a case report
Pubmed	<i>International Journal of Gynecology & Obstetrics</i> <i>British Journal of Sports Medicine</i> <i>Canadian Journal of Applied Physiology</i>	Exercise during pregnancy and postpartum period Guidelines of American college of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and postpartum period Joint SOGC/CSEP clinical practice guideline: exercise in pregnancy and postpartum period
Scopus	<i>Physical Therapy</i> <i>Fisioterapia</i>	An exercise and education program improves well-being of new mothers: a randomized controlled trial Actuación del fisioterapeuta durante la gestación, parto y postparto
Sport Discus CINAHL	<i>American Fitness</i> <i>Dissertation</i>	The postpartum challenge Efficacite des traitements physiotherapiques pour l'incontinence urinaire d'effort chez la femme en periode postnatale

de gestación se contempla el posparto. Así, el fisioterapeuta es el responsable de la realización de los programas de ejercicio posparto⁶.

Varios autores proponen para la prevención de las disfunciones del suelo pélvico los ejercicios de Kegel^{2,7}. Se trata de ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico con resistencias progresivas, presentando buenos resultados para restaurar la función después del parto y para la prevención de la incontinencia urinaria de esfuerzo^{8,9}.

La utilidad del fortalecimiento muscular de la musculatura pélvica quedó plasmada en un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado en 676 mujeres, donde el grupo experimental (348) recibió formación en ejercicios del suelo pélvico y el grupo control (328) siguió una atención habitual. A los 3 meses después del parto se observó que la prevalencia de disfunciones del suelo pélvico de las mujeres del grupo experimental era menor y su gravedad también¹⁰.

Así una Revisión Cochrane sobre el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico en ensayos con asignación al azar o cuasialeatorizados ha demostrado que tiene efectos positivos para la prevención y el tratamiento de la incontinencia fecal y urinaria¹¹.

Otro estudio muestra un caso de una paciente con 3 hijos, el último con cesárea, en que, tras un programa de

entrenamiento de 8 semanas, se aprecian mejoras funcionales cuantitativas y cualitativas¹². Asimismo, es primordial informar a la mujer garantizando así el correcto seguimiento del tratamiento¹³.

Aunque la iniciación de ejercicios del suelo pélvico en el posparto inmediato reduce el riesgo de futuras incontinencias urinarias, cabe destacar que si el entrenamiento muscular intensivo se realiza también durante el embarazo va a favorecer esta prevención de la incontinencia urinaria no solo durante la gestación, sino también después de dar a luz^{14,15}.

Al mismo tiempo, para la prevención de la incontinencia anorrectal y urinaria, junto con el trabajo muscular, se sugiere la adopción de la posición de Gasquet para facilitar la defecación, proponiéndose además la ingesta de abundante líquido y una alimentación rica en fibra².

Otros autores sugieren como medidas para la recuperación del tono de la musculatura pélvica la crioterapia, aunque no es tolerable por todas las mujeres¹³.

También se plantea el entrenamiento de la musculatura pélvica con técnicas de biofeedback y estimulación eléctrica, puesto que resulta eficaz y seguro para la musculatura del suelo pélvico. No obstante, algunos investigadores

solo aconsejan el biofeedback porque afirman que si existe un daño nervioso la electroestimulación puede producir un retraso en la recuperación^{2,16}.

Uno de los estudios revisados propone también los ejercicios de aspiración diafragmática descritos por Marcell Caufriez, los cuales se realizan en apnea espiratoria y en determinadas posturas facilitadoras de la relajación del diafragma, y por acción refleja, además, van a activar la musculatura del suelo pélvico².

Otra de las técnicas utilizadas en el posparto es el ultrasonido terapéutico, el cual puede disminuir el dolor en procesos inflamatorios, así como la reducción de la presión sobre las estructuras sensibles al dolor por hematoma o edema secundario al parto^{1,17}.

También se aconseja la utilización de una bola china, pues al ser introducida en el interior de la vagina esta estimulará los vibrorreceptores vaginales, desencadenando una contracción de la musculatura lisa de la vagina. Al mismo tiempo, el peso de la bola estimula los barorreceptores de la musculatura perineal, desencadenando un aumento del tono².

En el periodo del posparto se propone la realización de ejercicios con el bebé (Lechman), de forma que las recientes mamás hacen tareas con su bebé y en el caso de realizar estas actividades en grupo conocen gente en su misma situación^{7,18}.

Simplemente la realización de alguna actividad cardiorrespiratoria, como caminar entre 3 y 5 veces a la semana durante 20-30 min, tiene efectos positivos para la mujer tras el parto⁷. La realización de ejercicio supervisado por un fisioterapeuta junto con la educación de la paciente en nociones de salud contribuye a la mejora del bienestar y disminuye la depresión tras el parto^{18,19}.

Se incide también en la importancia de la postura a lo largo de la vida de la mujer²⁰. De hecho, un ensayo controlado y aleatorizado con 81 mujeres demostró que un enfoque individualizado de tratamiento mediante ejercicios específicos de estabilización pélvica es más efectivo que la terapia física en grupo. Los resultados mostraron que la estabilización pélvica reduce el dolor, mejora el estado funcional y mejora la calidad de vida²¹.

En general, la práctica de ejercicio físico, estiramientos, masoterapia, electroterapia, hidroterapia, termoterapia y fisioterapia respiratoria resulta beneficiosa como prevención y tratamiento de las complicaciones del posparto, pero también en el embarazo y en el parto. Por tanto, se pone de relieve la importancia de la actuación del fisioterapeuta en la mujer¹.

Ante los beneficios que reporta la fisioterapia en el posparto en la prevención de las disfunciones del suelo pélvico, debería de ser incluida en los equipos de Atención Primaria e incorporarse a los programas de salud de la mujer en el posparto².

Conclusiones

Tras esta revisión, se concluye que la fisioterapia como prevención de diversas afecciones tras el posparto está respaldada por numerosos autores; sin embargo, la publicación de trabajos científicos sobre el tema es escasa. Ello puede ser debido a que en algunos países no se ofrece el

servicio desde los centros sanitarios públicos hasta que aparece alguna afección en la mujer.

Los métodos terapéuticos más empleados en la prevención de disfunciones durante el periodo posnatal requieren tan solo del aprendizaje de ejercicios por parte de las mujeres, así como, el control de su realización periódicamente. Por lo tanto, la actuación por parte del fisioterapeuta no conlleva una sobrecarga a nivel asistencial, ni un elevado gasto sanitario.

Desde los ámbitos profesional y educativo, los fisioterapeutas debemos de esforzarnos en promocionar la actuación de la fisioterapia en la prevención y no solo en el tratamiento.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Las autoras declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

1. Romero-Morante M, Jiménez-Reguera B. Actuación del fisioterapeuta durante la gestación, parto y posparto. *Fisioterapia*. 2010;32:123-30.
2. Ferri A, Amostegui J. Prevención de la disfunción del suelo pélvico de origen obstétrico. *Fisioterapia*. 2004;26:249-65.
3. Wyman JF, Harkins SW, Fantl JA. Psychosocial impact of urinary incontinence in the community-dwelling population. *J Am Geriatr Soc*. 1990;38:282-8.
4. Marshall K, Walsh D, Baxter G. The effect of a first vaginal delivery on the integrity of the pelvic floor musculature. *Clin Rehabil*. 2002;16:795-9.
5. Estatuto del personal sanitario no facultativo de la Seguridad Social. Orden del 26 de abril de 1973. *Boletín Oficial del Estado*, n.º 102, de 28 de abril de 1973.
6. Martínez S, Martínez A, Gámez J. Fisioterapia en el primer nivel asistencial: atención a la mujer. *Rev Iberoam Fisioter Kinesiol*. 2001;4:43-7.
7. Reimer L. The postpartum challenge. *American Fitness*. 2007:58-61.
8. Kegel A. Progressive resistance exercise in the functional restoration of the perineal muscles. *Am J Obstet Gynecol*. 1948;56:238-48.
9. Kegel AH. Physiologic therapy for urinary stress incontinence. *J Am Med Assoc*. 1951;146:915-7.
10. Chiarelli P. Promoting urinary continence in women after delivery: randomized controlled trial. *BMJ*. 2002;324:1241.
11. Hay-Smith J, Fairbrother KA, Herbison GP. Entrenamiento de la musculatura del piso de la pelvis para la prevención y tratamiento de la incontinencia fecal y urinaria en mujeres antes y después del parto. *La Biblioteca Cochrane Plus*. 2008;4.

12. Brumitt J. A return to running program for the postpartum client: a case report. *Physiother Theory Pract.* 2009;25:310–25.
13. Perrier J, Poizat M, Richet C, Roubertie E, Schrub S. Rééducation dans le cadre du post-partum. *Gynécol Obstét Fertil.* 2003;31:1062–76.
14. American College of Obstetricians and Gynecologist. Exercise during pregnancy and the postpartum period. *Int J Obstet Gynecol.* 2002;77:79–81.
15. Mørkved S, Bø K, Schei B, Salvesen KA. Pelvic floor muscle training during pregnancy to prevent urinary incontinence: a single-blind randomized controlled trial. *Obstet Gynecol.* 2003;101:313–9.
16. Lee I, Choi E. Pelvic floor muscle exercise by biofeedback and electrical stimulation to reinforce the pelvic floor muscle after normal delivery. *Taehan Kanho Hakhoe Chi.* 2006;36:1374–80.
17. Hay -Smith J. Therapeutic ultrasound for postpartum perineal and dyspareunia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2000;2.
18. Norman E, Sherburn M, Osborne RH, Galea MP. An exercise and education program improves well-being of new mothers: a randomized controlled trial. *Phys Ther.* 2010;90:348–55.
19. Artal R, O'Toole M. Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period [discussion 12]. *Br J Sports Med.* 2003;37:6–12.
20. Britnell SJ, Cole JV, Isherwood L, Sran MM, Britnell N, Burgi S, et al. Postural health in women: the role of physiotherapy. *J Obstet Gynaecol Can.* 2005;27:493–510.
21. Dumoulin C. Efficacité des traitements physiothérapeutiques pour l'incontinence urinaire d'effort chez la femme en période post-natale [tesis doctoral]. Canada: Université de Montreal; 2004.